



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عزيزه مصطفى عبدالجواد عفيفي

العنوان : فيصل

الحي / المدينة : عين شمس

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

رقم البطاقة : 26809012100584 رقم التليفون : 01101638127

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-09-1968 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الاورام

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج الالم ومضادات القئ لمرضي
الاورام المنتشر [14456]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عزيزه مصطفى عبد الجواد عفيفي National ID: 26809012100584	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Pin Medication And Anti Emetics
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عزيزه
مصطفى عبد الجواد عفيفي
٤٤ ش. ابو شبلبي - فيصل
بولاق الدكرور - الجيزة

٢٦٨.٩.١٢١.٠٥٨٤

١٩٣٨/٠٩/٠٩

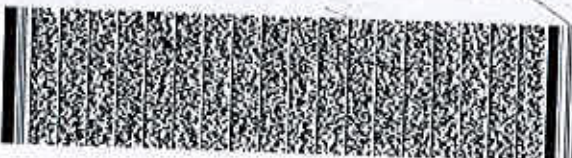
L05452753

٢٠٢٥/١١ ٢٦٨.٩.١٢١.٠٥٨٤

حاصله على دبلوم زراعه

أنتى
مستلمة
أرسله

٢٠٢٧/١٢/٣٠ البطاقة سارية حتى



Patient Name	: الأستاذة / عزيزة مصطفى عبد الجواد	Request No.	: 13007813
Patient No.	: 26809012100584	Request Date	: 13/05/2024
Path No.	: 1548/24	Verification Date	: 19/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 55 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered	: Dr. Aya Mohamed Youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

* Procedure: Left MRM measured 30x14x6 cm, with covering skin ellipse measured 24x14 cm.

* Tumor extent: A greyish white tumor bed site.

* Size: 7x4x3.5 cm.

* Skin: Nipple & areola looked unremarkable grossly.

Distance from margins: 3 cm away from deep margin.

Lymph nodes number and size: 21 L.Ns. up to 1.5x1x0.5 cm.

12 Blocks:

:7- T.B.S., 8- Deep margin., 9- N&A., 10:12- Lymph nodes.

Microscopic Examination:

Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.

Actual tumor cellularity: 0%.

Ductal carcinoma in situ: Not detected.

Skin: Free.

Lymph nodes: Positive viable metastatic deposits in 13 out of 21 lymph nodes, L.N (13/21).

No evidence of extra-nodal extension (The largest nodal metastasis is 8 mm).

Resection Margins: Free.

Histologic response to therapy: Pathological partial response to therapy.

Diagnosis:

Left breast cancer post NACT, Left modified radical mastectomy specimen.
No residual viable remnants of the previously diagnosed tumor.

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 25/05/2024 09:40:33

Page 1 of 2

Printing By : Mrs. Aya Mohamed

Room : 0. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt



Patient Name: Aziza Moustafa Abdel Gawwad Afify	Date : 24/09/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 3636/2023	24437

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

**** Reported history of left breast cancer.**

I Chest:

- Left breast UOQ small rather defined parenchymal nodular soft tissue lesion is seen measuring about 1.5 x 1.4 cm in maximum axial dimensions is seen.
 - Associated enlarged ipsilateral discrete and partly confluent axillary lymph nodes (level I, II and III) with largest one seen at level I measuring about 2.4 x 1.7 in maximum axial dimensions.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- Lingula mild bronchiectatic changes showing peribronchial thickening with related atelectatic bands.
- No sizable pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.



Patient Name: Aziza Moustafa Abriel Gawwad Afify	Date : 24/09/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAS	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 3636/2023	24437

- Normal appearance of the spleen, pancreas, kidneys (apart from left renal cortical cyst measuring about 3.6 x 2.9 cm), both suprarenals gland, aorta and I.V.C.
- Under filled urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No sizable pathologically enlarged pelvi-abdominal lymph nodes.
- No ascites.

Opinion:

**** Reported history of left breast cancer.**

- No definite pulmonary, hepatic or osseous deposits.

Dr. Ali Elsisy

Dr. Amr Farouk, M.D.

1

1	
---	--

1

1

7

TNM



1

1	
---	--

1

1

7

TNM

Psychiatric	
-------------	--

Name : Aziza Mustafa Abdeljawad Afifi
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 07-09-2026 11:56
Medical No. : 456295

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

Clinical Indication: 58-year-old female with left breast carcinoma, status post total mastectomy, chemotherapy, radiotherapy, and current hormonal therapy. Presents with severe right shoulder pain. Referred for skeletal evaluation.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views, following intravenous administration of $99mTc$ -MDP.

Findings:

- Scattered foci of increased tracer uptake are noted in the right upper ribs, mid-dorsal spine, and right ischium.
- Mild bilateral symmetric uptake is noted in wrists, knees, and ankles, consistent with degenerative changes.
- Renal excretion is prompt and symmetric. No abnormal soft tissue uptake.

Impression:

- Scattered osseous lesions involving ribs, spine, and pelvis—suspicious for metastatic disease in the setting of known breast carcinoma, for radiological correlation.
- Clinical correlation and oncology review are recommended.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

Name : Aziza Mustafa Abdeljawad Afifi

Date : 07-09-2026 11:56

Branch : Dokki

Medical No. : 456295

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

Clinical Indication: 58-year-old female with left breast carcinoma, status post total mastectomy, chemotherapy, radiotherapy, and current hormonal therapy. Presents with severe right shoulder pain. Referred for skeletal evaluation.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views, following intravenous administration of $99mTc$ -MDP.

Findings:

- Scattered foci of increased tracer uptake are noted in the right upper ribs, mid-dorsal spine, and right ischium.
- Mild bilateral symmetric uptake is noted in wrists, knees, and ankles, consistent with degenerative changes.
- Renal excretion is prompt and symmetric. No abnormal soft tissue uptake.

Impression:

- Scattered osseous lesions involving ribs, spine, and pelvis—suspicious for metastatic disease in the setting of known breast carcinoma, for radiological correlation.
- Clinical correlation and oncology review are recommended.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

مستشفى
الرياض
الرياض

أ.م.د.
أ.م.د.
أ.م.د.



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

مبادرة
الرئيس
الجمهورية

08/30/2026

MDT FORM

Name:	Aziza Mostafa Eabd Aljawad .	MRN:	428
Age:	58 Y	ID:	26809012100584
Menopausal Sta		Phone:	01104176628
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	

Clinical Data:

BX: R L

ER: PR: HER2: KI67:

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

57 YEARS OPLD FEMAE PT WITH LT BREAST CANCER IDC ER 8/8 PR 8/8 HER2-VE KI67 15%

T N M

CT2N1M0 received NACT (Ac X 4, Taxotere X4), Then t MRM with residuals 13/21 LN N3 Y AT 9/5/2024 received PORT and on adj AI for 2 YEARS MRI spine reveals multiple dorsal and umbar bone marrow infiltrative lesions low on t1 and t2

ct chest and abdomen and bone scan requested for mdt
Recommendations:

FOR IBRANCE FASLODEX ZOMETA EVERY 3 MS

MDT Outcome & Plan

FOR IBRANCE FASLODEX
ZOMETA EVERY 3 MS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Signature

Signature

